

CÓLICO NEFRÍTICO

Iria Miguéns Blanco, Domingo Sánchez Sendín, Raquel García Sánchez, Ana De Lorenzo Pinto.

INTRODUCCIÓN

El cólico nefrítico, cólico renal o cólico renoureteral hace alusión al dolor originado por el paso de un cuerpo sólido desde el riñón a las vías urinarias. Lo más frecuente es que sea un cálculo, aunque puede ser un coágulo de sangre, en el curso de una hematuria renal, o un fragmento de papila en el caso de una necrosis papilar.

Puede ser de causa intraureteral (litiasis, coágulos, pus, tumores, estenosis de la luz ureteral) o de causa extraureteral (vasculares, procesos digestivos, apendicitis, tumores, ginecológicos o retroperitoneales).

DIAGNÓSTICO

Presencia de dos o más de los siguientes datos: clínica sugestiva, exploración física positiva, hematuria.

Su diagnóstico se basará en:

- **Cuadro clínico:** se caracteriza por dolor agudo intenso intermitente, localizado en fosa renal, irradiado por el trayecto uretral ipsilateral del mismo lado hasta los genitales, puede presentar náuseas, vómitos y diaforesis. No se modifica con el reposo ni con los movimientos. Cuando el cálculo migra al uréter distal, donde se diagnostican el 75% de los cálculos, el dolor puede localizarse en la parte anterior del abdomen o en el área suprapúbica, los cálculos vesiculares pueden presentarse con disuria intermitente y hematuria terminal. Habrá que realizar el diagnóstico diferencial con otras causas urológicas (enfermedad vascular renal, torsión del cordón testicular) y no urológicas (disección aórtica, diverticulitis y apendicitis aguda)
- **Exploración física:** Afectación del paciente por dolor. Hiperalgnesia en fosa renal afecta, posible puño percusión renal positiva y dolor en hemiabdomen del lado afectado.

Pruebas complementarias

- Hemograma con fórmula leucocitaria.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, proteína C reactiva (PCR).
- Sedimento y sistemático de orina en el que se objetive hematuria microscópica.
- Hemocultivos y urocultivos si hay fiebre.
- Radiografía de abdomen para valorar el tamaño de siluetas renales y posibles cálculos radioopacos.
- Ecografía abdominal. Se solicitara si existe embarazo, fiebre, paciente trasplantado, paciente monorreno o diagnóstico dudoso de litiasis, deterioro de la función renal, escasa mejoría del dolor tras analgesia. No detecta cálculos medianos o pequeños < 5 mm.
- La tomografía computarizada helicoidal sin contraste tiene la mayor sensibilidad y especificidad. Si existe diagnóstico no concluyente con la ecografía abdominal y/o sospecha de otra patología.

TRATAMIENTO

Fundamental el control del dolor.

- Dexketoprofeno 50mg/ 8 horas iv o diclofenaco 75 mg / 12-24 horas o ketorolaco 30 mg/ 6-8 horas iv.
- Metamizol 1 vial de 5 mL / 8 horas iv.
- Paracetamol 1 gr IV cada 8h
- Si necesidad de opioides: tramadol 100 mg/2ml ampollas IV cada 8 horas o petidina 1 vial / iv o sc o cloruro mórfico 5 mg IV o hidromorfona 1mg IV.
- Control de náuseas y vómitos: Metoclopramida 10 mg/ 8 horas iv u Ondansetrón 4- 8 mg / 6-8 horas iv.

El tratamiento expulsivo con α -bloqueantes está indicado en la litiasis renal distal de menos de 7-10 mm con: Tamsulosina 0,4mg comprimidos cada 24 horas al acostarse, durante 30 días o terazosina 5 a 10mg cada 24h o doxazosina 4mg cada 24h.

Criterios de ingreso

- Si el dolor es persistente a pesar del tratamiento analgésico adecuado.
- Si se sospecha uropatía obstructiva.
- Sospecha de pionefrosis.
- Insuficiencia renal aguda.
- Presencia de fiebre en pacientes trasplantado, monorreno.

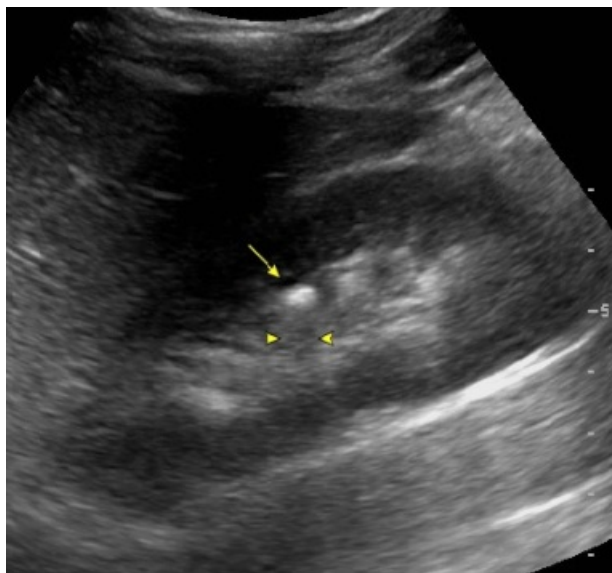
Recomendaciones al alta

Paciente que presenta mejoría clínica tras analgesia en urgencias sin datos de alteración analítica puede ser alta domiciliaria con las siguientes recomendaciones.

- Ingesta adecuada de líquidos.
- Analgesia oral, calor local.
- Control y seguimiento por su médico de atención primaria y derivación a consulta de urología.

¡Puntos clave!

- Se ha de establecer un correcto diagnóstico diferencial ante clínica compatible con cólico nefrítico. Sobre todo en aquellos pacientes cuyo primer episodio esté por encima de las edades características (excepcional en > 60 años).
- El control del dolor es fundamental. En los Servicios de Urgencias se hará una escalada más brusca del tratamiento analgésico pudiendo iniciar tratamiento con opioides.



Cálculo en parénquima renal.

Datos de la anamnesis que se relacionan con desenlace adverso.
Función renal en riesgo:
• Diabetes
• Hipertensión arterial
• Insuficiencia renal
• Riñón único
• Riñón en herradura
• Riñón trasplantado
Antecedentes litíasicos:
• Extracciones
• Endoprótesis
• Sondas de ureterostomía
• Litotricia
Síntomas de infección:
• Fiebre
• Hipotensión arterial
• Enfermedad sistémica
• Infección de vías urinarias

BIBLIOGRAFÍA

- Holdgate A, Pollock T. Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) versus opiáceos para el cólico renal agudo. (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008.Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: [http://: www.update-](http://www.update-)

software.com.

- Vázquez Lima, Manuel José. Casal Codesido, José Ramón. Guía de actuación en Urgencias. 4º edición. ; Esteve. Mayo 2013.
- Cydulka K. R, Fitch T. M, Joing S.A, Wang J.V, Cline M.D, John ma O. Tintinalli. Manual de medicina de urgencias. 8ª Edición. McGraw-Hill – 2018.